



Esofagites Específicas

Infecciosas, Medicamentosas e Cáusticas

Material didático para médicos em especialização em Gastroenterologia. Esta apostila abrange as principais formas de esofagite não relacionadas ao refluxo gastroesofágico, com foco em diagnóstico clínico, achados endoscópicos e condutas terapêuticas baseadas em evidências.

APOSTILA 1 — PÁGINAS 1 A 20

Introdução: Esofagites Não Relacionadas ao Refluxo

As esofagites não associadas ao refluxo gastroesofágico constituem um grupo heterogêneo e clinicamente relevante de condições inflamatórias do esôfago. Embora menos frequentes que a esofagite por refluxo, essas entidades representam desafios diagnósticos importantes, especialmente em pacientes imunossuprimidos ou com uso crônico de medicamentos.

Infeciosas

Fúngicas, virais e bacterianas. Predominam em imunossuprimidos.
Principais agentes: *Candida*, HSV, CMV.

Medicamentosas

Lesão direta da mucosa por comprimidos retidos. AINEs, antibióticos e bifosfonatos são os principais culpados.

Cáusticas

Ingestão acidental ou intencional de substâncias corrosivas.
Emergência com potencial de complicações graves.

Imunológicas

Incluem esofagite eosinofílica e outras condições mediadas por resposta imune alterada.

  Apesar de etiologias distintas, todas essas condições podem compartilhar manifestações clínicas comuns: **odinofagia, disfagia e dor retroesternal**. O contexto clínico do paciente é fundamental para o raciocínio diagnóstico.

Caso Clínico: Raciocínio Diagnóstico

PÁGINAS 4-5

O reconhecimento do contexto clínico é a chave para o diagnóstico das esofagites específicas. Considere o seguinte cenário:

Apresentação do Paciente

Paciente refere **odinofagia progressiva** há 7 dias, com disfagia para sólidos e líquidos. Relata uso recente de antibióticos de amplo espectro e corticoides sistêmicos para doença autoimune de base.

Hipótese Diagnóstica Principal

O conjunto de **imunossupressão medicamentosa** (corticoide + antibiótico) associado à sintomatologia esofágica sugere fortemente **esofagite infecciosa por Candida**. O antibiótico desequilibra a microbiota, enquanto o corticoide reduz a imunidade local da mucosa.

Conduta Inicial Sugerida

Endoscopia digestiva alta para confirmação e coleta de material. Iniciar **fluconazol oral empírico** enquanto aguarda resultado, especialmente se quadro clínico for compatível e paciente apresentar fatores de risco bem definidos.

Esofagite Infecciosa: Visão Geral

PÁGINAS 6 E 11

A esofagite infecciosa ocorre predominantemente em pacientes com algum grau de comprometimento imunológico. O entendimento dos grupos de risco e da apresentação clínica é essencial para o diagnóstico precoce.

Populações de Risco

- Imunossuprimidos (HIV/AIDS, transplantados)
- Diabéticos descompensados
- Pacientes em uso de corticoides sistêmicos
- Em uso de antibióticos de amplo espectro
- Pacientes em quimioterapia ou radioterapia
- Idosos com comorbidades múltiplas

Apresentação Clínica Típica

Os sintomas refletem a inflamação mucosa e variam conforme o agente causador e a extensão do acometimento:

- **Odinofagia:** sintoma cardinal, presente na maioria dos casos
- **Disfagia:** pode ser para sólidos ou líquidos dependendo da gravidade
- **Febre:** presente em infecções mais invasivas (CMV, HSV disseminado)
- **Perda de peso:** em quadros crônicos ou graves

A endoscopia digestiva alta com biópsia é o método padrão-ouro para confirmação diagnóstica e identificação do agente etiológico.

Esofagite por Cândida (Monilíase Esofágica)

INFECÇÃO ESOFÁGICA MAIS COMUM

PÁGINA 7

A candidíase esofágica é a infecção esofágica mais prevalente na prática clínica, causada predominantemente pela *Candida albicans*, fungo comensal oportunista que se torna patogênico em condições de imunossupressão local ou sistêmica.



Agente Etiológico

Candida albicans é responsável por mais de 90% dos casos. Outras espécies como *C. glabrata* e *C. tropicalis* são menos comuns, mas merecem atenção por resistência potencial ao fluconazol.



Sintomatologia

Odinofagia intensa é o sintoma predominante. Dificuldade para alimentação, especialmente com alimentos sólidos, é frequente. Pacientes imunossuprimidos graves podem ter sintomas atenuados.



Achados Endoscópicos

Placas esbranquiçadas aderidas à mucosa, de aspecto cremoso, que não se desprendem facilmente com lavagem. Pode haver inflamação difusa e, em casos avançados, confluência das placas com ulceração associada.

Classificação Endoscópica da Monilíase — Escala de Kodsi

PÁGINA 8

A classificação de Kodsi é amplamente utilizada na prática endoscópica para graduar a extensão e gravidade da candidíase esofágica. Ela orienta a conduta terapêutica e o prognóstico do paciente.

1

Grau I

Placas esbranquiçadas pequenas, elevadas, de até 2 mm, com hiperemia ao redor. Mucosa subjacente preservada.

2

Grau II

Placas maiores e confluentes, com edema e inflamação mais evidentes. Sem ulceração ou pseudomembrana.

3

Grau III

Placas confluentes em toda a extensão do esôfago, associadas a ulceração superficial. Mucosa frágil e friável ao toque.

4

Grau IV

Mucosa extremamente friável, com sangramento ao toque, ulcerações profundas e possível estenose luminal. Quadro grave com risco de complicações sistêmicas.

 **Pérola clínica:** O grau IV de Kodsi exige avaliação cuidadosa da extensão da imunossupressão e pode necessitar de antifúngico intravenoso desde o início do tratamento, além de investigação de candidemia associada.

Tratamento da Candidíase Esofágica

PÁGINA 9

O tratamento da candidíase esofágica é bem estabelecido e deve ser iniciado prontamente após o diagnóstico — ou mesmo de forma empírica em casos com alta suspeita clínica em pacientes imunossuprimidos.

Primeira Escolha

Fluconazol oral é o tratamento de primeira linha na maioria dos casos. Apresenta excelente biodisponibilidade oral e eficácia comprovada contra *C. albicans*.

- Dose: 200–400 mg/dia
- Duração: **14 a 21 dias**
- Via oral preferencial quando possível

Situações Especiais

Casos graves ou refratários: Utilizar antifúngicos intravenosos:

- Anfotericina B lipossomal
- Equinocandinas (caspofungina, micafungina)
- Voriconazol (em cepas resistentes)

Sempre investigar e tratar a causa base: controle glicêmico, revisão de imunossupressores, avaliação de HIV.

Resistência: Suspeitar de *C. glabrata* ou *C. krusei* em falhas ao fluconazol.

 **⚠ Ponto de atenção:** Todo paciente com candidíase esofágica sem causa aparente deve ser investigado para **HIV**. Em muitos casos, essa é a manifestação inaugural da infecção pelo vírus.

Esofagite por Herpes Simples (HSV)

SEGUNDA CAUSA MAIS COMUM

PÁGINAS 13-14

A esofagite herpética é causada predominantemente pelo **HSV tipo 1** e representa a segunda causa mais comum de esofagite infecciosa. Pode ocorrer tanto em imunossuprimidos quanto em indivíduos imunocompetentes, embora nestes seja geralmente autolimitada.

Apresentação Clínica

- Odinofagia intensa e súbita
- Febre e mal-estar geral
- Pode haver lesões herpéticas orolabiais associadas
- Náuseas e vômitos em alguns casos

Achados Endoscópicos

- Úlceras superficiais com aspecto **aftoide** (bordas bem delimitadas)
- Distribuição preferencial no terço médio e distal do esôfago
- Mucosa ao redor eritematosa e edemaciada
- Lesões podem ser múltiplas e confluentes em imunossuprimidos

Diagnóstico Histológico

- **Biópsia das bordas da úlcera** (região de epitélio viável)
- Achados: inclusões intranucleares, células gigantes multinucleadas
- Imuno-histoquímica confirma HSV
- PCR em tecido pode ser utilizado

Tratamento

- **Aciclovir** 400 mg 5x/dia ou 200 mg 5x/dia por **14 a 21 dias**
- Via IV em casos graves ou disfagia intensa
- Valaciclovir como alternativa oral
- Em imunocompetentes: pode ser autolimitado

Esofagite por Citomegalovírus (CMV)

PÁGINAS 15-17

A esofagite por CMV acomete quase exclusivamente pacientes com imunossupressão grave, especialmente transplantados de órgãos sólidos, pacientes com AIDS em fases avançadas ($CD4 < 50$ células/mm³) e pacientes em quimioterapia intensa. O CMV tem tropismo por células endoteliais e fibroblastos, explicando as úlceras profundas e extensas características da doença.

Características das Lesões CMV

- Úlceras **grandes, profundas** e bem delimitadas
- Podem ser únicas ou múltiplas
- Distribuição em qualquer segmento do esôfago
- Fundo da úlcera com exsudato fibrinoso
- Maior risco de sangramento e perfuração

Diagnóstico e Tratamento

Biópsia obrigatória do CENTRO da úlcera — diferença fundamental em relação ao HSV, onde a biópsia é feita nas bordas.

Achados histológicos: **inclusões intranucleares em "olho de coruja"** e inclusões citoplasmáticas.

Tratamento:

- **Ganciclovir IV** 5 mg/kg 12/12h por 21 dias — primeira escolha
- **Valganciclovir oral** como consolidação em casos selecionados
- **Cidofovir** como alternativa em resistência ou intolerância
- Foscarnet em casos de resistência ao ganciclovir

HSV vs. CMV: Diferenças Diagnósticas Fundamentais

PÁGINA 16

A distinção entre esofagite herpética e por CMV é de extrema importância clínica, pois os tratamentos são diferentes e um erro diagnóstico pode ter consequências graves em pacientes já fragilizados. O principal diferenciador prático é o **local da biópsia endoscópica**.



📌 **Regra mnemônica:** HSV → **B**orda (H e B, primeiras letras do alfabeto) | CMV → **C**entro (mesma letra inicial). Essa diferença reflete o tropismo celular distinto de cada vírus na histologia.

Esofagite Induzida por Medicamentos

CAPÍTULO: MEDICAMENTOSA

PÁGINA 20

A esofagite medicamentosa resulta do contato direto e prolongado de comprimidos ou cápsulas com a mucosa esofágica. Ocorre quando o medicamento não é deglutido adequadamente, permanecendo em contato com a mucosa por tempo suficiente para causar lesão química local.



AINEs e Aspirina

Inibição local de prostaglandinas protetoras da mucosa. Lesão direta por pH ácido do comprimido. Um dos grupos mais associados à esofagite medicamentosa.



Antibióticos

Doxiciclina e **clindamicina** são os mais frequentes. Alta osmolaridade e pH ácido causam lesão direta. Risco aumentado se tomado sem água e antes de deitar.



Sulfato Ferroso

Depósito de cristais de ferro na mucosa esofágica. Causa ulceração e pode levar a estenose em casos crônicos. Tomar sempre com bastante água e em posição ereta.



Bifosfonatos

Alendronato e outros bifosfonatos orais são causas clássicas. Requerem protocolo de ingestão rigoroso: em jejum, com copo cheio de água, permanecendo em pé por 30 minutos.

Mecanismo de Lesão, Quadro Clínico e Endoscopia

Mecanismo de Lesão

O mecanismo central é a **lesão direta da mucosa esofágica** pelo contato prolongado do comprimido com o epitélio. Fatores que aumentam o risco:

- Ingestão do medicamento com pouca ou nenhuma água
- Deglutição imediatamente antes de deitar (decúbito)
- Dismotilidade esofágica ou compressão extrínseca (ex: aumento do átrio esquerdo)
- Comprimidos de liberação controlada ou grandes cápsulas
- Hipossalivação (xerostomia)

Quadro Clínico

- **Dor retroesternal** intensa e de início súbito
- **Odinofagia** presente logo após a ingestão do medicamento
- Início típico: horas após a tomada do comprimido
- Paciente frequentemente consegue identificar o medicamento causador

Achados Endoscópicos

- Úlceras no **terço médio do esôfago** (estreitamento fisiológico)
- Lesões em "beijo" (úlceras opostas nas paredes anterior e posterior)
- Mucosa ao redor relativamente preservada

 **Tratamento:** Principalmente **sintomático** com analgésicos e proteção mucosa (sucralfato, IBP). A medida mais importante é a **suspensão do medicamento causador** e orientação sobre técnica correta de ingestão de comprimidos.

Esofagite Cáustica

EMERGÊNCIA MÉDICA

PÁGINA 23

A esofagite cáustica resulta da ingestão de substâncias corrosivas — acidental (especialmente em crianças) ou intencional (tentativa de suicídio em adultos). A soda cáustica (hidróxido de sódio) e os ácidos fortes são os agentes mais comuns. A gravidade da lesão depende do tipo de substância, concentração, volume ingerido e tempo de contato com a mucosa.

Álcalis (Soda Cáustica)

Causam **necrose liquefativa**: penetração profunda e progressiva nas camadas da parede esofágica. Maior risco de perfuração. Lesões mais extensas e graves.

Ácidos Fortes

Causam **necrose coagulativa**: formação de escaras que limitam a penetração. Lesão gástrica predominante. Lesão esofágica menor, mas ainda significativa.

Sintomas Agudos

Dor intensa na orofaringe, região retroesternal e epigástrico. Disfagia grave e sialorreia. Odinofagia, náuseas, vômitos. Estridor em casos com acometimento laringeo.

Complicações

Perfuração esofágica e mediastinite. Fístulas. Estenose esofágica cicatricial tardia (principal complicação crônica). Carcinoma esofágico a longo prazo.

Conduta Inicial na Esofagite Cáustica

PÁGINA 23

O manejo da ingestão cáustica é uma emergência médica e requer abordagem imediata, sistematizada e com conhecimento das condutas corretas — e das **contraindicações absolutas**.

1 Suporte Clínico Imediato

Acesso venoso, hidratação, analgesia e avaliação de vias aéreas. Monitorização rigorosa. Em casos graves, suporte intensivo em UTI. Avaliar necessidade de intubação orotraqueal precoce se houver acometimento laríngeo ou orofaríngeo extenso.

2 Endoscopia Diagnóstica Precoce

Realizada idealmente nas primeiras 12–24 horas para estadiamento da lesão. Permite classificar a gravidade (graus I a IIIb) e orientar prognóstico. Contraindicada em casos de perfuração suspeita ou instabilidade hemodinâmica.

3 Condutas Proibidas

NÃO realizar neutralização química (ex: dar ácido para neutralizar base): gera reação exotérmica que agrava a lesão. **NÃO realizar lavagem gástrica** ou indução de vômito: aumenta o contato da substância com a mucosa e risco de aspiração. **NÃO administrar carvão ativado**: ineficaz e dificulta endoscopia.

📌 ⚠️ **Contraindicações absolutas:** Neutralização química, lavagem gástrica e indução de vômito são medidas que **agravam o quadro** e devem ser evitadas mesmo que bem intencionadas. Educação da equipe de emergência é fundamental.

Complicações da Esofagite Cáustica: Estenose Esofágica

A estenose esofágica cicatricial é a complicação crônica mais frequente e clinicamente relevante da ingestão cáustica. Resulta da fibrose progressiva durante o processo de cicatrização tecidual nas semanas e meses após a lesão aguda.



O acompanhamento endoscópico seriado é fundamental para detectar e tratar a estenose precocemente. A **dilatação endoscópica** — com balão ou bougies de Savary — é o tratamento de escolha e pode ser necessária de forma repetida ao longo de meses a anos. Em casos refratários, considera-se **colocação de prótese esofágica** ou tratamento cirúrgico.

📌 O risco de desenvolvimento de **carcinoma espinocelular de esôfago** está aumentado em pacientes com estenose cáustica (risco 1.000x maior que a população geral), exigindo vigilância endoscópica a longo prazo.

Diagnóstico Diferencial: Comparativo das Esofagites

O contexto clínico e os achados endoscópicos são determinantes para diferenciar as principais formas de esofagite. A tabela a seguir resume os principais elementos distintivos para orientar o raciocínio diagnóstico na prática clínica.

Característica	Cândida	HSV	CMV	Medicamentosa
Perfil do paciente	Imunossuprimido, diabético, uso de ATB/corticoide	Imunossuprimido ou imunocompetente	Imunossupressão grave (AIDS, transplante)	Qualquer paciente em uso de medicação oral
Aspecto endoscópico	Placas brancas aderidas	Úlceras aftoides pequenas	Úlceras grandes e profundas	Úlceras em "beijo", terço médio
Local da biópsia	Placa (escovado/biópsia)	Borda da úlcera	Centro da úlcera	Não necessária em geral
Tratamento principal	Fluconazol oral 14–21 dias	Aciclovir 14–21 dias	Ganciclovir IV 21 dias	Suspender medicação causadora

Importância Clínica: Investigando a Causa Base

Toda esofagite infecciosa deve ser encarada como um sinal de alerta clínico. Além de tratar a infecção esofágica em si, o médico deve investigar sistematicamente a condição imunológica subjacente que permitiu o desenvolvimento da infecção.

Investigar HIV

Candidíase esofágica pode ser a manifestação definidora de AIDS. Solicitar sorologia HIV em todo paciente sem causa aparente de imunossupressão. CD4 < 200 células/mm³ é o principal fator predisponente para candidíase esofágica em pacientes HIV+.

Avaliar Controle Glicêmico

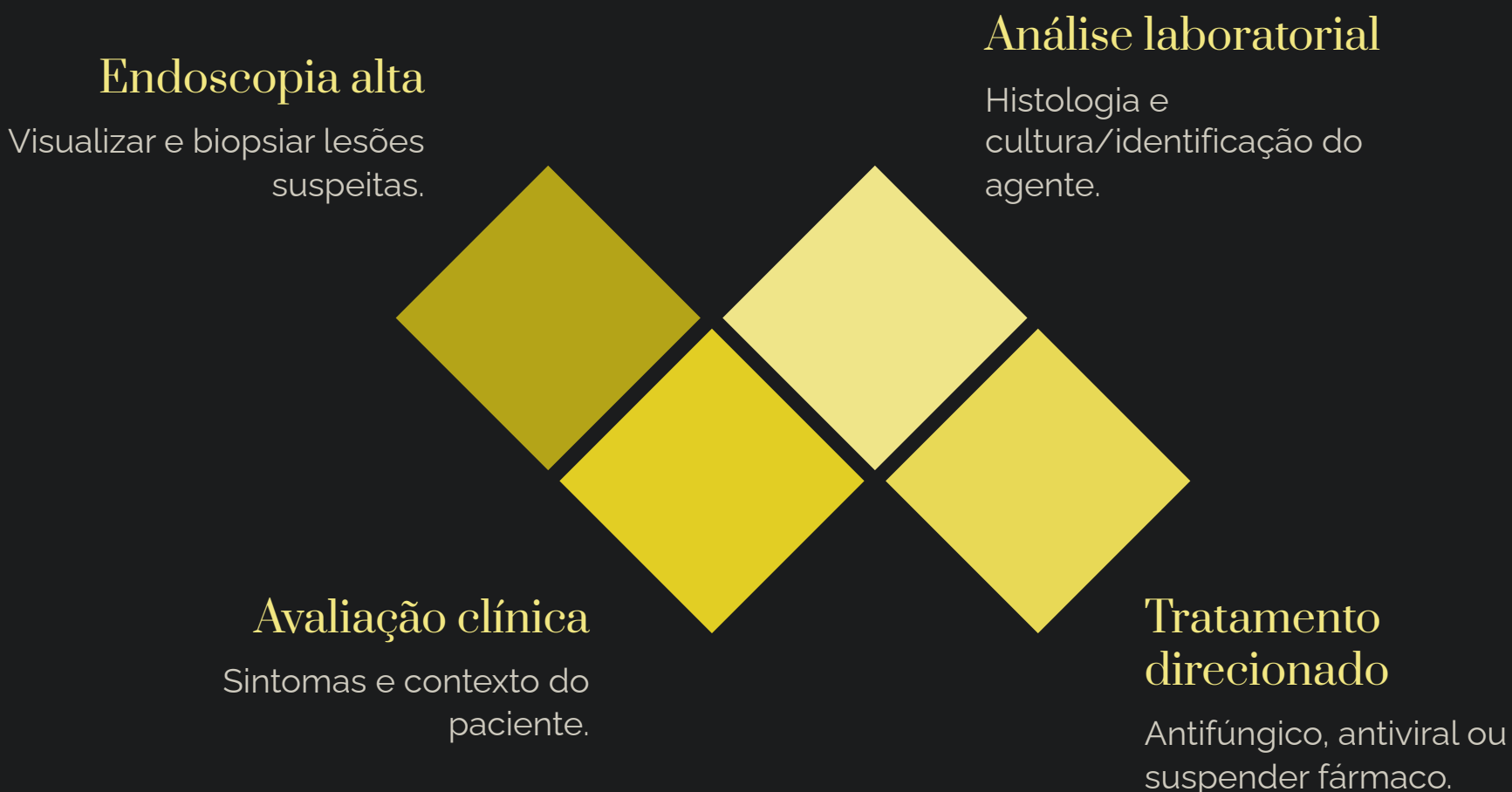
Diabetes mellitus descompensado altera a função de neutrófilos e macrófagos, favorecendo infecções fúngicas. Solicitar glicemia, HbA1c. Controle glicêmico rigoroso faz parte do tratamento da candidíase esofágica em diabéticos.

Revisar Medicamentos Imunossupressores

Corticoides sistêmicos, imunobiológicos, quimioterápicos e inibidores de calcineurina aumentam risco de infecções oportunistas. Avaliar possibilidade de redução da dose ou profilaxia antifúngica em pacientes de alto risco.

Abordagem Diagnóstica Sistematizada

A investigação das esofagites específicas deve ser estruturada e orientada pelo contexto clínico. O algoritmo diagnóstico abaixo resume os passos essenciais desde a suspeita clínica até a confirmação etiológica.



Quando realizar endoscopia imediata?

- Paciente imunossuprimido com odinofagia
- Suspeita de ingestão cáustica
- Sangramento digestivo alto associado
- Falha ao tratamento empírico inicial

Quando tratar empiricamente?

- Alta suspeita de candidíase (imunossuprimido + clínica típica)
- Paciente com AIDS e candidíase oral concomitante
- Endoscopia não disponível imediatamente
- Resposta clínica confirma diagnóstico presuntivo

Resumo dos Tratamentos: Guia Rápido

Síntese terapêutica para consulta rápida na prática clínica. Os protocolos de duração e escolha do agente devem ser individualizados conforme a gravidade e o contexto imunológico do paciente.

Candidíase Esofágica

1ª linha: Fluconazol 200–400 mg/dia VO por 14–21 dias

Grave/refratário: Equinocandinas IV ou Anfotericina B lipossomal

Atenção: Investigar HIV e tratar causa base

Esofagite por HSV

1ª linha: Aciclovir 400 mg 5x/dia por 14–21 dias

Grave: Aciclovir IV 5–10 mg/kg 8/8h

Biópsia: Borda da úlcera

Esofagite por CMV

1ª linha: Ganciclovir IV 5 mg/kg 12/12h por 21 dias

Alternativa: Cidofovir ou Foscarnet

Biópsia: Centro da úlcera

Esofagite Medicamentosa

Principal: Suspender medicação causadora

Sintomático: IBP + sucralfato + analgesia

Prevenção: Orientação sobre técnica de ingestão

Esofagite Cáustica

Emergência: Suporte clínico + endoscopia em 12–24h

PROIBIDO: Neutralização, lavagem gástrica, vômito

Crônico: Dilatação endoscópica seriada

Pontos-Chave e Referências

APOSTILA 1 — SÍNTESE FINAL

→ Contexto clínico é soberano

O perfil do paciente (imunossuprimido? qual medicação? ingestão de substância?) é o principal norteador diagnóstico antes mesmo da endoscopia.

→ Candidíase esofágica pode ser sinal de HIV

Sempre investigar sorologia HIV em paciente sem causa clara de imunossupressão que apresente candidíase esofágica.

→ O local da biópsia muda o diagnóstico

HSV → borda da úlcera. CMV → centro da úlcera. Erro no local da biópsia leva a resultado falso-negativo e retardo terapêutico.

→ Condutas proibidas no cáustico salvam vidas

Neutralização química e lavagem gástrica são contraindicações absolutas. Conhecer essas proibições é tão importante quanto conhecer o tratamento correto.

Referências: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED) | American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) Guidelines | Yamada's Textbook of Gastroenterology | Feldman: Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease | Protocolos clínicos de esofagites infecciosas e cáusticas | Kodsí BE et al. – Classificação endoscópica da candidíase esofágica.